

UFSC – SC – 2014

Residência Médica R1 – Prova 1

Prova com 100 questões · Documento gerado a partir de provaderesidencia.com.br

1. Assinale a alternativa CORRETA. Na tomografia computadorizada na pancreatite aguda, o grau D na classificação de Balthazar significa:

- A) inflamação peripancreática difusa.
- B) mais de duas coleções peripancreáticas.
- C) inflamação peripancreática mais uma única coleção líquida.
- D) endurecimento pancreático.
- E) inflamação pancreática focal.

2. Assinale a alternativa CORRETA. Nas lesões cáusticas do esôfago, a endoscopia digestiva alta:

- A) é recomendada a partir de 12 a 24 horas após a ingestão do cáustico.
- B) é recomendada a partir de uma semana após a ingestão do cáustico.
- C) é recomendada a partir de 48 horas após a ingestão do cáustico.
- D) é recomendada a partir de dois dias após a ingestão do cáustico.
- E) não é recomendada.

3. Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. Nas massas de glândula suprarrenal descoberta incidentalmente, incidentaloma, por métodos de imagem, com mais de cinco centímetros, qual seria a melhor conduta?

- A) Acompanhamento com método de imagem (TC).
- B) Tratamento cirúrgico.
- C) Laparoscopia diagnóstica.
- D) Arteriografia seletiva.
- E) PET-Scan.

4. Assinale a alternativa CORRETA. O tipo histológico mais comum de sarcoma retroperitoneal é:

- A) leiomiiossarcoma.
- B) fibrossarcoma.
- C) tumor maligno de bainha de nervo periférico.
- D) G.I.S.T.
- E) lipossarcoma.

5. Na realização de videolaparoscopia utiliza-se o gás dióxido de carbono. Em relação ao uso preferencial deste gás, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Tem melhor capacidade de distensão abdominal, portanto, proporciona melhor campo operatório.
- B) Tem associado menor risco de provocar a diminuição do débito cardíaco.
- C) Tem melhor difusão entre os tecidos proporcionando melhor dissecação destes.
- D) Não sofre combustão, é rapidamente eliminado do organismo, tem associado menor risco de embolia gasosa e é mais barato.
- E) Possui menor interação com as drogas anestésicas.

6. Em relação ao pseudocisto pancreático, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. () A principal causa em crianças é traumática e a maioria resolve-se espontaneamente. () O tratamento de drenagem somente está indicado se não existir involução do cisto em 12 semanas. () A parede do pseudocisto é epitelizada e ele é rico em amilase. () O tamanho inicial do cisto é preditor da possibilidade de involução deste. () A principal complicação do pseudocisto é a ascite pancreática em decorrência de uma fístula. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- A) V – F – F – V – V.
- B) F – F – F – V – F.
- C) F – F – V – V – F.
- D) F – V – V – F – F.
- E) V – V – V – F – V.

7. Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. A tríade de Whipple está associada a qual dos seguintes tumores?

- A) Insulinoma.
- B) Somatostatinaoma.
- C) Adenocarcinoma de pâncreas.
- D) Feocromocitoma.
- E) Glucagonoma.

8. Assinale a alternativa CORRETA. O fator de risco mais potente para o desenvolvimento do hepatocarcinoma é:

- A) hemocromatose.
- B) infecção pelo vírus da hepatite C.
- C) etilismo.
- D) ingestão de aflatoxinas.
- E) HBeAG do vírus da hepatite B positivo.

9. Assinale a alternativa CORRETA. A doença abdominal mais comum que requer cirurgia em uma gestante é:

- A)** colecistite aguda.
- B)** apendicite.
- C)** torção de ovário.
- D)** hérnia inguinal encarcerada.
- E)** colelitíase.

10. Em relação à cicatrização de feridas, assinale a alternativa CORRETA.

- A)** As fases de cicatrização são didaticamente divididas em fase inflamatória, proliferativa e maturação, elas ocorrem independentemente, nunca simultaneamente, e nem se sobrepõem, primeiro acaba uma fase para começar a outra.
- B)** A fase proliferativa se caracteriza por maior permeabilidade vascular, migração de células para a ferida por quimiotaxia e formação de tecido de granulação.
- C)** As cicatrizes hipertróficas são definidas como cicatrizes que crescem além das margens da ferida original, raramente regredindo com o tempo.
- D)** A fase inflamatória se caracteriza por maior permeabilidade vascular, migração de células para a ferida por quimiotaxia, secreção de citocinas e fatores de crescimento na ferida e ativação das células migrantes.
- E)** Na fase inflamatória ocorre angiogênese e fibroplasia, com processo de formação de novos vasos sanguíneos e quimioatração de fibroblastos para o local inflamatório.

11. Em relação à síndrome de dumping que pode ocorrer após gastrectomias, assinale a alternativa CORRETA.

- A)** A síndrome de dumping precoce ocorre devido à rápida passagem de conteúdo hiperosmolar da refeição ao intestino, causando sua distensão e uma resposta autonômica com sintomas como náuseas, diarreia explosiva, taquicardia.
- B)** A síndrome de dumping precoce deve ser tratada como opção principal com cirurgia que promova a redução da velocidade do esvaziamento gástrico.
- C)** A síndrome de dumping precoce acontece 2 a 3 horas após a refeição, sendo causada por hipoglicemia, e é mais comum que a tardia.
- D)** A síndrome de dumping tardia ocorre devido à chegada rápida de carboidratos ao intestino, provocando passagem de líquido do extracelular para a luz intestinal e tendo como sintoma clínico náuseas e vômitos.
- E)** A principal medida dietética no tratamento da síndrome de dumping precoce é a diminuição da ingestão de proteínas e gorduras.

12. Com relação à pancreatite crônica, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. () A causa mais comum é o uso abusivo de álcool e o sintoma mais presente é a esteatorreia. () A doença, quando no estágio C ou avançado, apresenta dor intensa com episódios frequentes e com perda da função endócrina e exócrina do pâncreas. () O teste da secretina-colecistoquinina é o método laboratorial mais sensível e específico para o diagnóstico da pancreatite crônica. () A tomografia computadorizada estabelece critérios de gravidade com a Escala de Cambridge. O tipo II apresenta o ducto pancreático principal ainda sem alterações, mas com alterações em três ou mais ramos do ducto principal. () O tratamento clínico inicial visa o controle da dor e a correção da insuficiência pancreática, utilizando enzimas pancreáticas associadas ao inibidor da bomba de prótons para melhorar sua efetividade. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- A)** V – F – V – F – V.
- B)** F – V – V – F – F.
- C)** V – V – F – V – F.
- D)** F – V – F – V – V.
- E)** F – F – V – V – V.

13. Paciente, 51 anos de idade, apresenta dor abdominal em mesogástrio, em faixa, associada a náuseas e vômitos. Icterícia progressiva. Nos exames de investigação encontra-se Ca 19-9 elevado. Tomografia computadorizada apresenta lesão expansiva em cabeça pancreática de 4,5 x 6 cm, preservando os vasos mesentéricos e portais, com presença de diversas lesões em ambos os lobos hepáticos sugestivas de implantes secundários. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o método de tratamento preconizado neste caso.

- A)** Biópsia guiada por tomografia das lesões hepáticas para confirmação de metástase e posterior cirurgia de derivação biliodigestiva.
- B)** Biópsia guiada por tomografia das lesões hepáticas para confirmação de metástase e posterior drenagem endoscópica da via biliar principal com uso de próteses.
- C)** Duodenopancreatectomia com preservação pilórica e biópsia das lesões hepáticas.
- D)** Tratamento imediato com quimioterapia e radioterapia.
- E)** Duodenopancreatectomia e ressecção das lesões hepáticas.

14. Em relação a cistos e abscessos esplênicos, assinale a alternativa CORRETA.

- A)** Cisto esplênico com Ca19-9 normal sugere origem epitelial.
- B)** A causa mais comum de abscessos esplênicos são as peritonites.
- C)** Cistos complexos, multiloculados estão associados às infecções bacterianas.
- D)** Cistos esplênicos sintomáticos ou maiores que 5 cm devem ser submetidos a intervenção cirúrgica.
- E)** O abscesso esplênico tem como principal tratamento a esplenectomia.

15. Em relação ao abscesso hepático, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. () O abscesso amebiano comumente é solitário e localizado no lobo hepático esquerdo. () O abscesso hepático piogênico tem suas taxas de mortalidade hospitalar elevadas quando apresenta leucocitose intensa, hiperbilirrubinemia, abscessos únicos e grandes, e ainda quando diabéticos. () A etiopatogenia mais comum do abscesso hepático piogênico é a disseminação de bactérias através do sistema porta. () O envolvimento do lobo hepático esquerdo é mais comum em pacientes com litíase intra-hepática. () O tratamento primário de abscessos amebianos é preconizado com monoterapia, utilizando apenas o metronidazol. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- A)** V – F – V – F – V.
- B)** F – F – V – V – V.
- C)** F – F – F – V – F.
- D)** V – V – V – F – F.
- E)** F – V – F – V – V.

16. Assinale a alternativa CORRETA em relação à cirurgia bariátrica.

- A)** O hiperparatireoidismo secundário pode ocorrer devido à deficiência na absorção de cálcio na dieta com aumento do PTH.
- B)** Para pacientes com diabetes mellitus tipo II, de difícil tratamento no Brasil, existe autorização para indicação de banda gástrica ajustável em pacientes com IMC superior a 30.
- C)** A hérnia de Petersen ocorre no orifício formado entre os mesentérios da alça biliopancreática e alimentar.
- D)** A diminuição observada de GLP-1 ocorre quando a sua absorção é realizada no duodeno, que está excluído do trânsito no By-pass gástrico em Y-Roux.
- E)** A grelina é um importante hormônio orexígeno e tem sua importante diminuição principalmente na Gastrectomia Vertical com a ressecção do antro gástrico.

17. Assinale a alternativa CORRETA. A regeneração do parênquima hepático após uma ressecção cirúrgica se dá por:

- A)** hipertrofia.
- B)** metaplasia.
- C)** neoplasia.
- D)** hiperplasia + metaplasia.
- E)** hiperplasia.

18. Assinale a alternativa CORRETA. O sangue venoso portal pode conter patógenos e toxinas entéricas neutralizadas no fígado por células que agem como macrófagos residentes. Essas células são:

- A)** hepatócitos.
- B)** de Kupfer.
- C)** colangiócitos.
- D)** endoteliais dos vasos hepáticos.
- E)** hepáticas estelares.

19. Assinale a alternativa CORRETA. O percentual aproximado de portadores de cálculos na vesícula biliar que são assintomáticos é de:

- A)** 99%.
- B)** 10%.
- C)** 5%.
- D)** 80%.
- E)** 2%.

20. Assinale a alternativa CORRETA. Em pacientes criticamente enfermos com empiema da vesícula, a melhor opção terapêutica é:

- A)** tratamento clínico inicial e colecistectomia eletiva posteriormente.
- B)** papilotomia endoscópica.
- C)** coledocotomia com dreno de Kehr.
- D)** colecistostomia + papiloesfinteroplastia.
- E)** colecistostomia com tubo e colecistectomia quando melhorar.

21. Assinale a alternativa CORRETA. Uma investigação simultaneamente realizada em dois grupos de indivíduos, um grupo com portadores de uma dada patologia e outro sem a mesma patologia, pareados por diversas variáveis, entre elas a idade, o sexo e a ocupação, indagou sobre a presença ou a ausência de uma série de fatores relacionados com a patologia ao longo dos últimos 10 anos. Trata-se de um estudo:

- A)** caso e controles.
- B)** transversal.
- C)** coorte controlada.
- D)** ensaio clínico.
- E)** estudo ecológico.

22. Assinale a alternativa CORRETA. Homem, 46 anos, 1,80 m de altura, 66 kg, não fumante, que pratica exercício regularmente, sem história familiar de doença vascular isquêmica, sem queixas, pede para fazer exames de colesterol de rotina, pois seu colega de trabalho enfartou recentemente. Após avaliação clínica, com todas as aferições dentro da normalidade, foi orientado a não realizar a dosagem de colesterol, já que não apresenta outros fatores de risco cardiovascular. A conduta pode ser considerada prevenção:

- A)** secundária.
- B)** primária.
- C)** quaternária.
- D)** primordial.
- E)** terciária.

23. Temos hoje no Brasil, cerca de 50 milhões de jovens entre 10 e 24 anos (IBGE, Censo 2010), este é um grupo populacional sujeito a uma série de riscos que são refletidos em indicadores de saúde. Assinale a alternativa CORRETA sobre este grupo etário.

- A)** A mortalidade por causas endocrinometabólicas cresce com a obesidade e figura entre as mais importantes.
- B)** As principais causas de mortes por causas externas são os suicídios e afogamentos.
- C)** A mortalidade é maior por causas infecciosas e a AIDS é a principal causa.
- D)** A mortalidade está relacionada com a dependência de drogas, mormente do crack.
- E)** As causas externas (acidentes e violências) são a maior causa de mortes, sendo bem maior entre pessoas do gênero masculino.

24. Sobre o Planejamento em Saúde, analise as afirmativas abaixo. I. O Planejamento em Saúde na América Latina teve como propostas iniciais o racionamento econômico mediante redução dos custos na área da saúde. II. O Planejamento Estratégico, além de incorporar as noções do planejamento normativo, leva em consideração a integração econômica, política e social e a análise de viabilidade. III. O planejamento em saúde é tido como um instrumento que limita a equipe de saúde, pois ela precisa se preocupar com outras atribuições além de prestar atendimento à população. Assinale a alternativa CORRETA.

- A)** Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- B)** Somente as afirmativas I e II são corretas.
- C)** Somente as afirmativas I e III são corretas.
- D)** Somente a afirmativa II é correta.
- E)** Somente as afirmativas II e III são corretas.

25. A Programação Anual de Saúde é hoje o documento norteador da atenção à saúde nos diversos níveis de gestão no Brasil e deve conter: I. a definição das ações que, no ano específico, irão garantir o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde. II. o estabelecimento das metas anuais relativas a cada uma das ações definidas. III. a identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento da Programação. IV. o estabelecimento de fundamentação teórico-metodológica específica. V. a definição dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento da Programação. Assinale a alternativa CORRETA.

- A)** São corretas apenas as afirmativas II e IV.
- B)** São corretas apenas as afirmativas III, IV e V.
- C)** São corretas apenas as afirmativas IV e V.
- D)** São corretas apenas as afirmativas I, II, III e V.
- E)** São corretas apenas as afirmativas I, II, IV e V.

26. Assinale a alternativa CORRETA. Em bioestatística, é denominada como estatisticamente significativa a associação entre duas variáveis, quando:

- A)** as variáveis apresentam uma relação que pode ser considerada relevante em termos clínicos ou populacionais.
- B)** um dos fatores analisados pode ser considerado como causa do outro.
- C)** foi observada no contexto de um ensaio clínico randomizado, no qual todos os possíveis fatores que influenciam a associação foram devidamente controlados.
- D)** os valores de uma variável dependem dos valores da outra, havendo uma situação de dependência estatística entre elas.
- E)** a probabilidade de que esta associação tenha ocorrido ao acaso seja menor do que algum valor crítico previamente definido como, por exemplo, 5% ou 1%.

27. Assinale a alternativa CORRETA. Diversos parâmetros biológicos, entre eles o peso e a altura dos indivíduos, apresentam comportamento semelhante ao que se costuma rotular, em bioestatística, como distribuição normal. São propriedades da distribuição normal:

- A)** ter forma simétrica e apresentar média, mediana e moda com valores semelhantes.
- B)** apresentar área constante sob a curva, que impede o cálculo de probabilidades relacionadas à ocorrência de observações situadas em alguma faixa de valor.
- C)** permitir, para os parâmetros que possuem distribuição normal, o cálculo de diferenças de médias a partir de testes estatísticos não paramétricos.
- D)** refletir a distribuição de parâmetros ou variáveis, que se apresentam altamente concentrados em uma parcela da população, como a renda familiar.
- E)** ter sua distribuição completamente determinada pela mediana e pelo desvio-padrão.

28. Assinale a alternativa CORRETA. O valor de p (probabilidade) e o intervalo de confiança são recursos estatísticos que permitem:

- A)** avaliar se a pesquisa foi realizada com rigor, definindo a qualidade dos resultados obtidos.
- B)** extrapolar ou generalizar os resultados observados em uma amostra para alguma população de referência.
- C)** identificar se os fatores de risco investigados em uma pesquisa são, de fato, as verdadeiras causas da doença em questão.
- D)** conferir se os testes estatísticos empregados no estudo estão corretos.
- E)** examinar se as variáveis analisadas são categóricas ou numéricas.

29. Assinale a alternativa CORRETA. No Brasil, o Acolhimento na Atenção Primária à Saúde (APS) está relacionado principalmente à qualificação das relações entre profissionais e usuários, e também a:

- A)** atender e resolver os problemas de todos os usuários do dia.
- B)** prover consulta médica a todos os demandantes do dia.
- C)** criar triagem médica para avaliar rapidamente todos os usuários.
- D)** aumentar a equidade e o acesso ao cuidado apropriado.
- E)** melhorar a ambiência para que todos possam esperar confortavelmente.

30. Sobre a Estratégia Saúde da Família, é CORRETO afirmar que:

- A)** apresenta cobertura de 80% da população brasileira.
- B)** é considerada uma forma de organização da APS equivalente aos centros de saúde existentes antes da sua implantação.
- C)** significa hoje, aproximadamente, 70% da APS brasileira.
- D)** expandiu-se inicialmente nos grandes municípios.
- E)** vincula as pessoas às equipes de APS tanto por listas de usuários quanto por endereços domiciliares.

31. Assinale a alternativa CORRETA. A mortalidade infantil é importante indicador social em saúde coletiva. Quando ela é baixa, em torno de 10 por 1.000 nascidos vivos, predominam as mortes no período:

- A)** infantil tardia (após 6 meses).
- B)** neonatal tardia (de 7 até 28 dias).
- C)** infantil precoce (até 10 dias).
- D)** infantil tardia (28 dias até 1 ano).
- E)** perinatal (0 a 6 dias).

32. Em relação às medicinas alternativas e complementares, é CORRETO afirmar que:

- A)** a sua procura aumentou e continua aumentando de forma sustentada nas últimas décadas sem declínio da procura ou da confiança na ciência e na biomedicina.
- B)** estão em progressivo desuso à medida que se democratiza o cuidado biomédico.
- C)** sua procura aumentou devido à baixa qualidade do cuidado médico.
- D)** a ciência já estudou a maioria delas e apenas algumas, como a acupuntura, devem ser respeitadas, pois têm explicações e comprovação científica.
- E)** a ciência já é e deve ser o único critério de validação e legitimação de técnicas de cuidado na sociedade.

33. Assinale a alternativa CORRETA. A participação popular, um dos princípios do SUS, significa que:

- A)** todos os serviços de saúde públicos serão gerenciados por um Conselho de Saúde com representantes da população.
- B)** há Conferências de Saúde periódicas nos três níveis de governo que aprovam os orçamentos respectivos da saúde e propõem diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do Sistema.
- C)** nos Conselhos de Saúde os representantes da população têm metade dos votos e os profissionais de saúde a outra metade.
- D)** os Conselhos de Saúde nos três níveis de governo têm caráter deliberativo e fiscalizador, e metade dos membros desses conselhos são representantes dos usuários.
- E)** os votos dos Conselhos de Saúde são divididos metade para representantes da população e a outra metade é repartida entre representantes da administração pública (governo), dos médicos e dos agentes comunitários de saúde.

34. Sobre a história do cuidado médico à saúde no Brasil, assinale a alternativa CORRETA.

- A)** Os centros de saúde, no Brasil, inicialmente tinham funções de prevenção, educação sanitária e controle de doenças endêmicas (doenças infecciosas e coletivamente importantes).
- B)** Essa cultura preventivista e restrita à saúde pública foi superada com a exitosa implantação da Estratégia Saúde da Família, que universalizou o acesso ao cuidado médico no Brasil.
- C)** As Caixas de Aposentadoria e Pensão, fundadas na década de 1950, foram unificadas durante a ditadura militar.
- D)** O INPS, depois INAMPS, fornecia cuidado médico apenas aos trabalhadores com carteira assinada.
- E)** A medicina privada (liberal), eminentemente especializada após as décadas de 1970 e 1980, não marginalizou a medicina de família e comunidade, que continuou a ser requisitada pelos grupos de alta renda.

35. Sobre as causas ou determinações dos adoecimentos, é CORRETO afirmar que:

- A)** a ideia de unicausalidade das doenças surgiu no meio do século XIX com o movimento da medicina social, em meio à revolução industrial, a rápida urbanização da Europa e as péssimas condições de vida.
- B)** a ideia de determinação social da saúde, hoje, está cada vez mais reforçada pelos achados que correlacionam indicadores de saúde-doença com hierarquia e desigualdade social.
- C)** no modelo chamado "campo da saúde", da década de 1970, a atuação dos serviços de saúde associada aos determinantes biológicos responde por aproximadamente 50% da determinação da saúde.
- D)** a determinação genética vem sendo revalorizada como mais importante do que era no final do século XX, devido aos avanços da epigenética e da engenharia genética.
- E)** a determinação social da saúde é uma visão que não influencia o cotidiano do trabalho dos médicos, mas enriquece a visão sanitária dos governos e da saúde pública.

36. Assinale a alternativa CORRETA. Mulher, 55 anos, 3 filhos amamentados no peito por mais de um ano, assintomática e sem risco aumentado para câncer de mama, solicita esclarecimentos, pois leu na internet que mamografia de rotina pode gerar danos como o sobrediagnóstico e sobretratamento. O médico acerta ao orientar que:

- A)** esses danos, embora teoricamente possíveis, na prática não são significativos e que essas informações não são confiáveis. Ela deve, sim, fazer rastreamentos periódicos após os 50 anos.
- B)** esses danos não existem e que prevenir com exames periódicos é uma conduta que deve ser realizada e traz benefícios inegáveis.
- C)** de fato, recentes evidências de boa qualidade questionaram a indicação de rastreamento de câncer de mama com mamografia, mudando a indicação de recomendada para contraindicada.
- D)** os danos podem ocorrer, mas são principalmente de natureza psicológica e temporários (até comprovação diagnóstica), sendo o sobrediagnóstico mínimo ou teórico: não há motivo para dúvida.
- E)** esses e outros danos podem ocorrer e que há fundamento na dúvida, devido às recentes evidências a respeito. Não obstante, o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamografia após os 50 anos.

37. Em relação aos atributos da Atenção Primária à Saúde (APS), assinale a alternativa CORRETA quanto ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil.

- A)** O acesso deve ser fácil e a APS no Brasil está razoável, com 2000 pessoas por equipe de Saúde da Família.
- B)** Integralidade significa que as pessoas devem ser atendidas independentemente do tipo de problema que apresentem e a exigência recente de título de Medicina de Família e Comunidade para o trabalho na ESF responde a esse atributo.
- C)** A adscrição territorial da Estratégia Saúde da Família (ESF), em tese, satisfaz ao atributo da longitudinalidade, vinculando usuários a uma equipe personalizada.
- D)** atualmente a ESF tem função filtro e isso satisfaz ao atributo da coordenação do cuidado, na prática.
- E)** A orientação familiar e comunitária e a adequação cultural são contempladas pela formação médica brasileira de graduação, centrada hoje na APS.

38. Sobre os programas organizados de rastreamento (screening) e os rastreamentos oportunistas, assinale a alternativa CORRETA.

- A)** Os programas de rastreamento costumam ser mais efetivos porque há um domínio maior da informação e os passos ao longo dos níveis de atenção estão bem estabelecidos e pactuados.
- B)** Os rastreamentos oportunistas são menos onerosos para o sistema de saúde como um todo, já que não exigem organização burocrática, uma vez que podem ser realizados pelos próprios médicos nos seus encontros clínicos.
- C)** Programas organizados de rastreamento são menos efetivos no impacto sobre a morbidade e à mortalidade atribuídas à condição rastreada do que os rastreamentos oportunistas.
- D)** O rastreamento oportunístico é aquele que ocorre quando a pessoa procura o serviço de saúde com queixas ou sinais associados à condição a ser rastreada e o profissional de saúde solicita ou realiza o teste ou exame.
- E)** Os programas organizados de rastreamento têm sido a tônica da maioria dos serviços de saúde no mundo.

39. Homem, 50 anos, vem à consulta médica em Unidade de Saúde da Família com queixa de polidipsia e poliúria; traz exame recente de Glicemia de Jejum (GJ) com resultado de 118 mg/dl, pelo que o médico diagnostica Diabetes Mellitus (DM). Sobre a probabilidade de acerto diagnóstico, ou Valor Preditivo Positivo (VPP), nesses casos, é CORRETO afirmar que:

- A)** pode ser calculada conhecendo-se a sensibilidade e a especificidade dos sintomas e da GJ, no valor tomado como ponto de corte, para o diagnóstico de DM, e a incidência da DM na Área de Saúde da Família, informação que não é registrada no SIAB.
- B)** pode ser calculada conhecendo-se a sensibilidade e a especificidade dos sintomas e da GJ, no ponto de corte adotado, para o diagnóstico de DM, sem necessidade de conhecer a prevalência da DM na Área de Saúde da Família em que reside o paciente.
- C)** pode ser calculada conhecendo-se simplesmente a sensibilidade e a especificidade da GJ, no ponto de corte adotado, para o diagnóstico de DM, uma vez que independe da prevalência da DM, e incluir esses valores para os sinais e sintomas observados não modifica o VPP.
- D)** pode ser calculada conhecendo-se a sensibilidade e a especificidade dos sintomas e da GJ, no valor tomado como ponto de corte, para o diagnóstico de DM, e a prevalência da DM na Área de Saúde da Família, informação registrada na Ficha A do Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB).
- E)** não pode ser calculada.

40. Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um marcador do Sistema de Informação da Atenção Básica, e os médicos das Equipes de Saúde da Família devem notificar os casos confirmados ocorridos na sua Área de Saúde da Família. Como esse registro pode contribuir para a clínica médica e quais suas limitações?

- A)** A frequência relativa de casos de AVC ocorridos na população é uma prevalência e representa a carga da doença na população da Área de Saúde da Família. Embora seja de utilidade para o planejamento e a organização da atenção, é de pouca utilidade para a clínica, uma vez que não representa o risco de uma pessoa sofrer AVC.
- B)** A frequência relativa de casos de AVC ocorridos na população é a incidência acumulada, e representa o risco médio de um paciente sofrer AVC se todos os moradores usarem a Unidade de Saúde da Família. Sua principal limitação é a alta flutuação aleatória em populações pequenas quando o evento é raro.
- C)** A frequência relativa de casos de AVC ocorridos na população é a densidade de incidência, e representa o risco instantâneo de um paciente sofrer AVC, se todos os moradores usarem a Unidade de Saúde da Família. Sua principal limitação é a subnotificação de casos.
- D)** O número absoluto de casos de AVC permite prever a ocorrência de um novo caso na população, independente da atuação médica, pelo que tem pouca aplicação clínica. Sua principal limitação é a subnotificação de casos.
- E)** A frequência relativa de casos de AVC ocorridos na população é a prevalência, e representa o risco médio de um paciente sofrer AVC, se todos os moradores usarem a Unidade de Saúde da Família. Sua principal limitação é a alta flutuação aleatória em populações pequenas quando o evento é raro.

41. Gestante de 33 semanas teve diabetes gestacional diagnosticado com 26 semanas. Com orientação de dieta e atividade física, apresenta o perfil glicêmico quinzenal normal. Realiza exame ultrassonográfico que demonstra um feto macrossômico. Assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA.

- A)** Corticoterapia.
- B)** Ajuste da dieta e da atividade física.
- C)** Manter conduta atual, pois a macrossomia deve ser constitucional.
- D)** Pesquisar cromossomopatia.
- E)** Insulinoterapia.

42. Quanto ao D-dímero em gestantes, na suspeita de tromboembolia pulmonar, assinale a alternativa CORRETA.

- A)** Não tem utilidade clínica, pois seu nível varia muito na gravidez.
- B)** Está fisiologicamente aumentado, mas reduz no terceiro trimestre.
- C)** Mantém seu valor preditivo negativo.
- D)** Possui um bom valor preditivo positivo.
- E)** Possui grande valor diagnóstico, já que a arteriografia está contraindicada.

43. Quanto à sexualidade humana, assinale a alternativa CORRETA.

- A)** O Modelo terapêutico PLISSIT, de Annon, preconiza a permissão, liberação intencional, sugestão sexual e terapia analítica.
- B)** Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina estão indicados no tratamento do desejo sexual hipoativo.
- C)** A homossexualidade é o exemplo mais comum do distúrbio de identidade sexual.
- D)** No modelo do ciclo de resposta sexual de Masters e Johnson, a primeira fase é a motivação.
- E)** Disforia de gênero deve ser tratada com cirurgia.

44. Quanto à trombocitopenia gestacional, assinale a alternativa CORRETA.

- A)** Caracteriza-se pela ausência de uma glicoproteína de membrana das plaquetas.
- B)** Não necessita tratamento.
- C)** O uso de prednisona está indicado.
- D)** A trombocitopenia fetal pode estar presente.
- E)** Administração profilática de plaquetas está indicada quando abaixo de 50.000 por mm³.

45. Primíngesta assintomática, com 25 semanas, realiza exame ultrassonográfico que demonstra: gestação única, líquido amniótico, exame morfológico e Doppler normais. Colo uterino apresenta medida longitudinal de 18 mm, sem abertura do orifício cervical interno. Assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA que possui grau de recomendação A, para evitar a prematuridade.

- A)** Repouso físico e sexual.
- B)** Circlagem do colo uterino.
- C)** Tratamento de vaginose com metronidazol.
- D)** Progesterona via vaginal.
- E)** Isoxsuprina via oral.

46. Quanto à hipertensão na gravidez, com base em evidências, assinale a alternativa CORRETA.

- A)** O uso do Ácido acetil-salicílico pode prevenir a pré-eclampsia em grupos selecionados.
- B)** O tratamento com drogas anti-hipertensivas nos quadros leves ou moderados melhoram os resultados perinatais.
- C)** A dieta hipossódica é recomendável para a paciente com pré-eclampsia.
- D)** Os inibidores de conversão da angiotensina devem ser mantidos nas pacientes que já faziam uso.
- E)** Antioxidantes (vitaminas C e E) podem reduzir a incidência de pré-eclampsia.

47. Uma gestante hipertensa, com 36 semanas, procurou a emergência da maternidade com dor súbita abdominal e sangramento vaginal escurecido em grande quantidade. Ao exame obstétrico, o útero apresentava-se hipertônico, de consistência lenhosa e os batimentos cardíacos fetais estavam presentes. Ao toque vaginal não havia dilatação cervical. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e a conduta CORRETOS para o caso.

- A)** Placenta prévia total – cesariana de urgência.
- B)** Descolamento prematuro de placenta – inibição com uterolíticos.
- C)** Descolamento prematuro de placenta – cesariana de urgência.
- D)** Placenta prévia total – histerectomia puerperal.
- E)** Rotura uterina – indução de parto.

48. Assinale a alternativa CORRETA. Uma paciente comenta que seu ovário direito foi removido durante a cesariana porque apresentava dentes e cabelos. Trata-se provavelmente de:

- A)** cisto dentoide.
- B)** teratoma maduro.
- C)** cisto piloide.
- D)** teratoma imaturo.
- E)** coriocarcinoma.

49. Mulher, 42 anos, percebeu aumento da mama esquerda, com endurecimento focal, rubor e calor há 3 meses. Há duas semanas houve piora do quadro com febre e ulceração local com saída de secreção purulenta. Realizou mamografia que revelou "classificação de Bi-rads IV". Assinale a alternativa CORRETA quanto à conduta do caso acima.

- A)** Biópsia incisional e exame histopatológico.
- B)** Repetir a mamografia após tratamento com antibióticos de amplo espectro.
- C)** Complementar exame com ultrassonografia de mama.
- D)** Mamotomia.
- E)** Cultura da secreção e ressonância nuclear magnética.

50. Mãe procurou ginecologista levando sua filha de 17 anos que não menstruou ainda. Ao exame, o médico evidenciou distribuição de pelos típica para a idade em axilas e genitais. Mamas e vulva de aspecto normal para a idade. Ao toque, vagina muito curta em fundo cego. Solicitou o cariótipo e o resultado foi: 46, XX. O diagnóstico MAIS PROVÁVEL para o caso é:

- A)** síndrome de Morris.
- B)** síndrome de Turner.
- C)** disgenesia gonadal mista.
- D)** hiperplasia adrenal congênita.
- E)** síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser.

51. Paciente, 57 anos, menopausada há 7 anos, sem uso de reposição hormonal, apresentou sangramento vaginal por 4 dias, que cessou espontaneamente. Realizou uma ultrassonografia transvaginal na qual foi evidenciada imagem compatível com pólipos de endométrio. Assinale a alternativa que contém a MELHOR CONDUTA nesse caso.

- A)** Curetagem semiótica
- B)** Histerectomia
- C)** Progestogênio contínuo
- D)** Histeroscopia com biópsia
- E)** Reposição hormonal

52. Valdirene, 17 anos, está recebendo alta da maternidade após 48 horas de parto normal. Dentre as orientações sobre contracepção durante o período de aleitamento materno exclusivo, assinale a alternativa que apresenta os métodos indicados CORRETAMENTE.

- A)** DIU de cobre, contraceptivo oral combinado (estrógeno e progesterona), preservativo masculino.
- B)** DIU de cobre, preservativo masculino, progestágeno isolado.
- C)** DIU de cobre, progestágeno contínuo, contraceptivo injetável combinado mensal (estrógeno e progesterona).
- D)** Sistema intrauterino com levonorgestrel, progestágeno injetável trimestral, contraceptivo oral combinado (estrógeno e progesterona).
- E)** Na verdade nenhum método contraceptivo é necessário durante o aleitamento materno exclusivo devido ao bloqueio efetivo do eixo hipotálamo-hipófise-gônada causado pela ocitocina.

53. De acordo com o Manual de Ginecologia Endócrina da FEBRASGO (2010), na investigação de amenorreia, após excluir a possibilidade de gravidez, alguns exames são solicitados. Assinale a alternativa que contenha CORRETAMENTE exames complementares ditos essenciais.

- A)** LH, TSH, prolactina e progesterona plasmática.
- B)** FSH, prolactina e progesterona plasmática.
- C)** LH, TSH e prolactina.
- D)** FSH e LH.
- E)** FSH, TSH, prolactina e glicemia de jejum.

54. Adolescente, iniciou com ciclos menstruais aos 13 anos, apresenta ciclos menstruais menores que 21 dias e período menstrual maior que 8 dias. Estes eventos são respectivamente e CORRETAMENTE denominados:

- A)** Espaniomenorreia e metrorragia.
- B)** Polimenorragia e metrorreia.
- C)** Polimenorreia e hipermenorreia.
- D)** Menorragia e espaniomenorreia.
- E)** Opsomenorreia e hipermenorragia.

55. Assinale a alternativa CORRETA. O agente causador da Donovanose é:

- A)** Chlamydia trachomatis.
- B)** Haemophilus ducreyi.
- C)** Neisseria gonorrhoeae.
- D)** Klebsiella granulomatis.
- E)** Herpes simplex vírus.

56. Assinale a alternativa CORRETA. A indicação mais comum para pressário vaginal é:

- A)** Prolapso de órgão pélvico.
- B)** Divertículo uretral.
- C)** Incontinência anal.
- D)** Distúrbio anorretal funcional.
- E)** Fístula retovaginal.

57. Assinale a alternativa CORRETA. Os cistos hidáticos de Morgagni são remanescentes do(a):

- A)** Ducto mesonéfrico.
- B)** Ducto mulleriano.
- C)** Apêndice vesicular.
- D)** Seio urogenital.
- E)** Vesícula vitelínica.

58. Na assistência ao parto, é CORRETO afirmar que:

- A)** Na primípara, o apagamento e a dilatação cervical são sinônimos.
- B)** Nas multíparas, o colo uterino não se esvaece em sincronismo com a dilatação.
- C)** O secundamento geralmente dura 30 minutos e se maior que 60 minutos de duração deve ser considerado prolongado.
- D)** A revisão da vagina deve ser sistemática.
- E)** O recomendado é não ter conduta ativa no secundamento.

59. Gestante a termo, em trabalho de parto, com dilatação total há 20 minutos e apresentação fetal cefálica fletida no plano +2 de DeLee, variedade de posição OP, líquido meconial e cardiotocografia ilustrada na figura. Assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA. (VER IMAGEM)

- A)** Situação fetal não tranquilizadora, indicar cesariana.
- B)** Usar o fórcepe de Kielland.
- C)** Provável situação fisiológica, aguardar evolução via vaginal.
- D)** Infundir ocitocina para encurtar o período expulsivo.
- E)** Realizar manobra de Kristeller .

60. Gestante a termo, em trabalho de parto, com dilatação total há 20 minutos e apresentação fetal cefálica fletida no plano +2 de DeLee, variedade de posição OP, líquido meconial e cardiotocografia ilustrada na figura (VER IMAGEM). Após a condução obstétrica da gestante, nasce um menino com bom tônus muscular e chorando forte. Com 90 minutos de vida, a criança encontra-se gemente, com taquipneia e leves tiragens intercostais. Sobre o distúrbio respiratório deste recém-nascido, é CORRETO afirmar que:

- A)** a radiografia de tórax é fundamental para diagnóstico. A presença de hiperinsuflação, infiltrado intersticial e líquido na cissura pleural direciona para outra causa, que não o de aspiração meconial.
- B)** a história e o quadro clínico são característicos de aspiração meconial. Está indicado aspirar a traqueia para confirmação diagnóstica.
- C)** as boas condições de nascimento excluem a possibilidade de doença respiratória. Trata-se provavelmente de desconforto adaptativo.
- D)** entre as possibilidades diagnósticas estão taquipneia transitória e síndrome do desconforto respiratório, a duração da sintomatologia determinará o diagnóstico diferencial.
- E)** devido à presença de líquido amniótico meconial, está indicado início de antibioticoterapia até elucidação diagnóstica.

61. Uma gestante tem diagnóstico de toxoplasmose aguda com 24 semanas. Assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA.

- A)** Controle sem medicação, pois o risco nesta idade gestacional é mínimo.
- B)** O teste de avidéz vai determinar a necessidade de tratamento.
- C)** A espiramicina trata a doença fetal e a pirimetamina evita a transmissão vertical.
- D)** O Doppler da artéria cerebral média é importante para a avaliação fetal.
- E)** Prescrever espiramicina e programar amniocentese.

62. Uma gestante tem diagnóstico de toxoplasmose aguda com 24 semanas. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo. Após o nascimento, a toxoplasmose congênita para o filho da gestante relatada...

- A)** Terá seu diagnóstico afastado na criança assintomática, pois o comprometimento fetal naquela idade gestacional é evidente.
- B)** Pode estar presente sem sinais clínicos evidentes, como ocorre em cerca de 85% dos recém-nascidos com a doença.
- C)** Pode apresentar-se com a tríade clássica da doença: coriorretinite, hidrocefalia e cardiopatia.
- D)** Será excluída como possibilidade diagnóstica se a mãe seguiu rigorosamente a orientação obstétrica.
- E)** Deverá sempre ser investigada, porém o tratamento de início no período neonatal dependerá da sintomatologia observada.

63. Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. Uma criança saudável recebeu esquema de vacinação completo no primeiro ano de vida de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação vigente no Brasil em 2013. Com que idade, de acordo com este calendário, a criança deve receber o primeiro reforço da vacina DTP e em qual apresentação é recomendada a vacina para este reforço?

- A)** Aos 15 meses – vacina tetravalente (DTP + Hib).
- B)** Aos 15 meses – vacina pentavalente (DTP + Hib + Hepatite B).
- C)** Aos 18 meses – vacina DTP.
- D)** Aos 15 meses – vacina DTP.
- E)** Aos 24 meses – vacina DTP.

64. Assinale a alternativa CORRETA. Recém-nascido a termo de 2 horas de vida apresenta desconforto respiratório. FC 178 bpm; FR 62 irpm e pulsos normais nos 4 membros; fígado palpável de consistência normal, há 1 cm do rebordo costal direito. Radiografia de tórax com infiltrado pulmonar, sem cardiomegalia. À gasometria, pH 7,06; pO₂ 28 mmHg e saturação de 50%. Fornecido oxigênio a 100% por 10 minutos, a pO₂ sobe para 158 mmHg. O diagnóstico inicial é:

- A)** Transposição das grandes artérias.
- B)** Síndrome de obstrução do coração esquerdo.
- C)** Doença pulmonar.
- D)** Síndrome de obstrução do coração direito.
- E)** Persistência do canal arterial.

65. Paciente masculino, 4 anos de idade, chega na emergência com queixa de cefaleia e edema de face há 2 dias. Hoje, vomitou uma vez após o café da manhã. Anamnese revela que há 10 dias apresentou um pico febril, foi à emergência e teve diagnóstico de faringoamigdalite. Foi medicado com amoxicilina por sete dias. No terceiro dia de tratamento houve desaparecimento da febre. Ao exame físico: bom estado geral, afebril, pálido ++/4+, acianótico, anictérico, hidratado, taquidispneico. Edema bipalpebral bilateral. FR 32 irpm e FC 120 bpm. Coração BRNF PA 160 x 75 mmHg, Pulmões ESC em ambas as bases. Fígado 3 cm RCD. Edema ++ em membros inferiores. Exames complementares: Raio X de tórax: congestão cardiopulmonar e aumento da área cardíaca. Parcial de urina densidade 1015 pH 5.5; Leucócitos 18.000/mm³; Hemácias 120.000/mm³; Cilindros hemáticos raros; Bactérias: raras; Ureia 50 mg/dl; Creatinina 2 mg/dl; Na 140 mEq/L e K 5 mEq/L. Hemoglobina 9 g/dl e Hematócrito 28. Leucócitos 10.000/mm³. Assinale a alternativa CORRETA.

- A)** A hipótese mais provável é glomerulonefrite difusa aguda. O paciente deve ser internado com controle rigoroso de PA, diurese, balanço hídrico e dieta pobre em sódio.
- B)** A hipótese mais provável é síndrome hemolítico-urêmica e deve-se internar o paciente e iniciar tratamento dialítico devido à insuficiência renal.
- C)** A hipótese mais provável é pielonefrite e deve-se iniciar tratamento com ceftriaxone.
- D)** A hipótese mais provável é nefrite intersticial aguda pós uso de amoxicilina e deve-se iniciar corticoterapia.
- E)** A hipótese mais provável é doença de Berger e deve-se iniciar corticoterapia.

66. Um lactente com 45 dias de vida, em aleitamento materno exclusivo, é levado à consulta pediátrica com história de irritabilidade, distensão abdominal e fezes com muco e raias de sangue. Ao exame físico apresentava-se em bom estado geral, eutrófico, mas pálido, sem outras alterações significativas. O pai tem asma e a irmã apresentou história de alergia alimentar. Qual o diagnóstico mais provável?

- A)** Divertículo de Meckel.
- B)** Má formação vascular do intestino.
- C)** Doença inflamatória intestinal.
- D)** Cólica do lactente.
- E)** Alergia à proteína do leite de vaca.

67. Um lactente com 45 dias de vida, em aleitamento materno exclusivo, é levado à consulta pediátrica com história de irritabilidade, distensão abdominal e fezes com muco e raias de sangue. Ao exame físico apresentava-se em bom estado geral, eutrófico, mas pálido, sem outras alterações significativas. O pai tem asma e a irmã apresentou história de alergia alimentar. Qual o melhor procedimento diagnóstico?

- A)** Cintilografia.
- B)** Dieta materna isenta da proteína do leite de vaca, seguida do teste de provocação oral.
- C)** Angiografia.
- D)** Provas de atividade inflamatória e dosagem de imunoglobulinas.
- E)** Dosagem de IgE específica para leite de vaca.

68. Você é chamado na unidade de internação pediátrica para avaliar um lactente de 6 meses, internado por uma pneumonia, que está cianótico. Ele está com máscara não reinalante, com gasping (respiração não eficaz). Você não palpa pulso central. Qual é sua conduta, se tiver alguém para auxiliá-lo?

- A)** Inicia compressões torácicas seguidas por ventilação com pressão positiva com máscara facial num ritmo de 15 compressões e 2 ventilações.
- B)** Inicia compressões torácicas seguidas por ventilação com pressão positiva com máscara facial num ritmo de 30 compressões e 2 ventilações.
- C)** Inicia compressões torácicas seguidas por ventilação com pressão positiva com máscara facial num ritmo de 3 compressões e 1 ventilação.
- D)** Aumenta o fluxo da máscara não reinalante para 15 l/min, posiciona via aérea e pede para prepararem nebulização com broncodilatador.
- E)** Ventila com pressão positiva e máscara facial e faz atropina 0,02 mg/Kg/dose.

69. Você é chamado na unidade de internação pediátrica para avaliar um lactente de 6 meses, internado por uma pneumonia, que está cianótico. Ele está com máscara não reinalante, com gasping (respiração não eficaz). Você não palpa pulso central. Quando você faz monitorização cardíaca deste paciente e o monitor mostra o seguinte traçado: (VER IMAGEM). Mas o paciente continua sem pulso central. Qual é o distúrbio de ritmo apresentado por este paciente e qual o tratamento de escolha?

- A)** Trata-se de atividade elétrica sem pulso e a droga de escolha é atropina 0,02 mg/kg/dose EV, seguida por epinefrina 0,01 mg/kg/dose EV.
- B)** Trata-se de atividade elétrica sem pulso e o tratamento de escolha é desfibrilação com 2 J/kg.
- C)** Trata-se de uma bradicardia sintomática e o tratamento de escolha é atropina 0,02 mg/kg/dose EV.
- D)** Trata-se de uma bradicardia sintomática e o tratamento de escolha é a cardioversão elétrica com 1 J/kg.
- E)** Trata-se de uma atividade elétrica sem pulso e a droga de escolha é epinefrina 0,01 mg/kg/dose EV.

70. Criança de três anos de idade, previamente hígida, inicia com lesões purpúricas em região glútea, membros inferiores e face, além de hematúria discreta. O pai relata coriza serosa e tosse há cerca de 17 dias. Ht 34,8%; Hb 11,7 g/dl; Leucócitos 10.000/mm³ (eosinófilos 2%, bastões 1%, segmentados 30%, linfócitos 65%, monócitos 2%); contagem de plaquetas 18.000/mm³; TAP 80%; tempo parcial de tromboplastina ativada de 25 segundos (controle de 24 segundos). Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a principal hipótese diagnóstica.

- A)** Púrpura de Henoch Shönlein.
- B)** Leucemia linfoblástica aguda.
- C)** Púrpura trombocitopênica imune.
- D)** Síndrome hemolítico urêmico.
- E)** Síndrome de Wiskott-Aldrich.

71. Uma criança com três anos é levada ao serviço de emergência com quadro clínico de intoxicação, caracterizado por vômitos, diarreia e visão borrada. O exame físico revelou pupilas puntiformes, sialorreia, sudorese e miofasciculações. Estava normotérmica. A família relatou o uso de veneno na salsicha para matar ratos. Pelo quadro clínico é fácil identificar o mecanismo do veneno envolvido, identificar a síndrome que o paciente está apresentando. O médico deve ligar para o Centro de Informações Toxicológicas da região, iniciar imediatamente o uso de antídoto e solicitar exame laboratorial que confirme o diagnóstico. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE a síndrome clínica, o antídoto e o exame laboratorial a ser solicitado.

- A)** Síndrome adrenérgica, antídoto atropina, nível de mercúrio em urina de 24h.
- B)** Síndrome colinérgica, antídoto atropina, atividade sérica de acetilcolinesterase.
- C)** Síndrome colinérgica, antídoto N-acetilcisteína, dosar a atividade da colinesterase.
- D)** Síndrome anticolinérgica, antídoto atropina, nível urinário de anticoagulante.
- E)** Síndrome anticolinérgica, antídoto atropina, dosar a atividade da colinesterase.

72. Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. Paciente de seis anos, sexo masculino, deu entrada no pronto atendimento com queixa de dispneia aos moderados esforços há um ano. A genitora negou febre, tosse, obstrução nasal ou outros sintomas associados. Diurese normal. Ao exame físico encontrava-se em bom estado geral, estrófico, eupneico, acianótico, FC 98 bpm; PA 95/60 mmHg. Ausculta pulmonar normal. À ausculta cardíaca, a pediatra percebeu sopro sistólico ++/6 em foco pulmonar e segunda bulha desdobrando fixo. Fígado no rebordo costal direito e pulsos palpáveis e simétricos. Solicitou Raio X de tórax que evidenciou aumento de área cardíaca ++/4 e fluxo pulmonar aumentado +/4. Diante do caso apresentado, qual cardiopatia abaixo é compatível com o descrito?

- A)** Estenose pulmonar moderada.
- B)** Estenose aórtica leve.
- C)** Comunicação interventricular muscular pequena.
- D)** Veia cava superior esquerda persistente.
- E)** Comunicação interatrial tipo ostium secundum.

73. Assinale a alternativa CORRETA. Lactente feminina de 11 meses, previamente saudável, é levada à consulta por febre alta de início súbito. Na noite anterior estava chorosa e irritada. A paciente frequenta creche e há relato de algumas crianças febris na classe da menina. Ao exame apresenta 39.6°C, o pulso é 130/min, a frequência respiratória é de 30 irpm, coriza hialina, hiperemia conjuntival bilateral e linfadenomegalia occipital discreta. É orientado tratamento sintomático apenas. Três dias após o início da febre, a criança retorna por rash macular eritematoso de início em tronco e que depois estendeu-se para membros e face. O diagnóstico provável é:

- A)** varicela.
- B)** sarampo.
- C)** eritema infeccioso.
- D)** exantema súbito.
- E)** rubéola.

74. Mãe traz ao pediatra o filho de onze anos relatando emagrecimento, enurese e astenia. Glicemia capilar de 370 mg/dl. Neste caso, é CORRETO afirmar que:

- A)** o diagnóstico é diabetes mellitus tipo I e o tratamento com insulina não deve ser adiado.
- B)** é necessário avaliar os níveis de insulina basal para afastar a possibilidade de diabetes mellitus tipo II.
- C)** é necessário um teste oral de tolerância à glicose para confirmar o diagnóstico de diabetes mellitus tipo I.
- D)** é necessário avaliar a hemoglobina glicada, que geralmente está normal nestes casos.
- E)** solicitar glicemia de jejum para confirmar o diagnóstico de diabetes mellitus tipo I.

75. Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. Dos componentes da vacina pentavalente (DPT + Hib + Hep B), utilizada rotineiramente pela Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis em 2013, qual provoca efeitos colaterais significativos, mais frequentemente?

- A)** Diftérico
- B)** Tétano
- C)** Pertussis
- D)** Hemófilos
- E)** Hepatite B

76. Um lactente, sexo masculino, 6 meses de idade, consulta no ambulatório porque uma semana antes vinha apresentando episódios de flexão do tronco e membros, em sequências de até 10 contrações, especialmente ao despertar. Os pais notaram que naquelas últimas duas semanas havia deixado de sorrir e de levar as mãos aos objetos. Uma ultrassonografia fetal no último trimestre de gestação havia mostrado massas no interior das cavidades cardíacas. Ao exame físico apresentava cinco manchas cutâneas hipocrômicas de limites bem definidos e formas irregulares de até 3 cm em membros inferiores e abdome. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a principal hipótese diagnóstica.

- A)** Esclerose tuberosa.
- B)** Neurofibromatose tipo I.
- C)** Melanose neurocutânea.
- D)** Doença de Sturge-Weber.
- E)** Doença de Pompe.

77. Assinale a alternativa CORRETA. Os principais ácidos graxos responsáveis por melhor desempenho em testes cognitivos após idade pré-escolar de crianças que foram amamentadas exclusivamente ao seio são:

- A)** ácido duodecanoico e ácido octanoico.
- B)** ácido butanoico e ácido tetradecanoico.
- C)** ácido triacontanoico e ácido caproico.
- D)** ácido butírico e ácido láurico.
- E)** ácido docosahexaicoico e ácido araquidônico.

78. Assinale a alternativa CORRETA. Uma criança deve sentar sem apoio e apresentar reações equilibratórias a partir do:

- A)** primeiro trimestre de vida.
- B)** terceiro trimestre de vida.
- C)** segundo semestre de vida.
- D)** quinto trimestre de vida.
- E)** quarto trimestre de vida.

79. Assinale a alternativa CORRETA. João, 8 meses de idade, consulta com a queixa de pouco ganho de peso. Ao avaliar, você constata, após anamnese e avaliação do estado nutricional, que o lactente apresenta desaceleração do crescimento. Frente ao bom estado geral, você procede a investigação ambulatorialmente. Ao retorno com os exames, você constata como positivos uma hemoglobina 9,5 g/dl e VCM de 65 μ 3 sugerindo anemia ferropriva. Entre os fatores dietéticos que predispõem à anemia carencial nesta faixa etária, você deve inicialmente pesquisar:

- A)** introdução tardia da gema de ovo.
- B)** ingestão insuficiente de hortaliças.
- C)** ingestão insuficiente de vitaminas lipossolúveis.
- D)** ingestão de grandes volumes de leite de vaca não modificado.
- E)** ingestão insuficiente de vitaminas hidrossolúveis.

80. Assinale a alternativa CORRETA. Mariana, 5 meses de idade, apresenta-se à consulta com um quadro clínico de desnutrição grave, dermatite descamativa, periorifical e em extremidades. Nos antecedentes, sua história alimentar informa ter feito uso de leite de vaca diluído ao meio e adoçado com açúcar, desde o nascimento até os 4 meses, e após leite de vaca a 2/3. Nesse período há relato de episódios de diarreia e infecções respiratórias. Os sinais clínicos do exame físico são indicativos de deficiência importante de:

- A)** riboflavina.
- B)** zinco.
- C)** niacina.
- D)** ferro.
- E)** tiamina.

81. Paciente masculino, 63 anos, procura ambulatório de Clínica Médica por queixa de "cansaço" progressivo no último ano. Há quatro meses percebeu que não estava conseguindo fazer atividades habituais; consultou-se no Posto de Saúde e foi diagnosticado com anemia, sendo receitado sulfato ferroso. Usou por um mês e parou por conta por estar sentindo epigastralgia. Hipertenso, em uso de atenolol. Sem outros antecedentes pessoais ou familiares significativos. Nega vícios e relata boa alimentação. Ao exame físico, chama atenção apenas palidez cutâneo-mucosa ++/4. Laboratório: Hb = 8.7 g/dl; Ht = 26.4%; VCM = 112; Leucócitos = 3.300/mm³ e Plaquetas = 165.000/mm³. Perfil de ferro dentro da normalidade. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao caso clínico e à interpretação da síndrome anêmica.

- A)** A dosagem de homocisteína e ácido metilmalônico auxiliam na investigação de anemia macrocítica.
- B)** Pela análise do perfil de ferro, a reposição está sendo eficaz e este tratamento deve ser mantido, devendo o paciente ser orientado a associar omeprazol ao sulfato ferroso.
- C)** Anemia megaloblástica por deficiência de folato deve ser considerada e pode se manifestar com sintomas neurológicos.
- D)** A anemia por deficiência de cobalamina nos idosos ocorre principalmente pela baixa ingestão desta vitamina na dieta.
- E)** Pacientes que tiveram ressecção do íleo terminal podem desenvolver anemia perniciosa.

82. Medicamentos antidepressivos são amplamente utilizados na medicina, não apenas para o tratamento de transtornos psiquiátricos, mas também para dores crônicas, doenças reumáticas e funcionais gastrointestinais. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o efeito colateral anticolinérgico de intoxicação por antidepressivo tricíclico.

- A)** Miose.
- B)** Emagrecimento.
- C)** Bradicardia.
- D)** Incontinência urinária.
- E)** Constipação.

83. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação clinicossorológica CORRETA nas hepatites virais:

- A)** HBsAG-/anti-HBc total+/anti-HBs- = contato prévio com o vírus da hepatite B.
- B)** HBsAG-/anti-HBc total+/anti-HBs+ = imunidade artificial (vacina para hepatite B).
- C)** HBsAG+/HBeAG+/anti-HBc+/anti-HBe-/anti-HBs- = portador inativo da hepatite B.
- D)** anti-HCV+ = portador do vírus da hepatite C.
- E)** HBsAG-/anti-HBc total-/anti-HBe-/HBeAG-/anti-HBs+ = imunidade natural pós-infecção por hepatite B.

84. Com relação às doenças dermatológicas na atenção básica à saúde, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. () Escabiose é uma parasitose que acomete preferencialmente as regiões interdigitais, axilas, região periumbilical, sulco interglúteo e órgãos genitais externos, com prurido intenso e caracteristicamente noturno. () Mííase ou "berne" é uma zoodermatose causada por larvas de moscas, que ocorre na pele, mucosas ulceradas e nas cavidades. () Ptíriase versicolor é uma micose superficial comum que acomete a raiz dos membros, pescoço e tronco, que tem como característica ao exame físico o sinal de Zileri. () Tinea corporis caracteriza-se por lesões ulceradas com exsudato, comum em áreas pobres em saneamento básico. () Molusco contagioso em adultos pode estar relacionado à imunossupressão pelo HIV. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- A)** F – V – V – F – V.
- B)** V – F – V – V – V.
- C)** V – V – F – V – F.
- D)** V – V – F – F – V.
- E)** V – V – V – F – V.

85. Paciente masculino, 51 anos, é trazido pelos bombeiros por "vômito com sangue" em grande quantidade. Foi resgatado desacordado e entra na emergência do HU sonolento, relatando tontura, náuseas e mal-estar. Familiar refere que o paciente queixa-se de epigastria há cerca de um ano, usando ranitidina quando a dor fica mais intensa, com alívio parcial. Hipertenso em uso de losartan. Nega internações prévias, histórico familiar ou vícios. Sinais vitais à admissão: PA 90/60 mmHg; FC 120 bpm; FR 22 irpm; T 35.7°C; Sat O₂ 95%. Ht inicial: 27%. Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. No atendimento de hemorragia digestiva alta em uma unidade de emergência, qual a melhor conduta inicial?

- A)** Encaminhar para Unidade de Terapia Intensiva para estabilização do paciente.
- B)** Contatar serviço de endoscopia digestiva para diagnóstico, tratamento e solicitação de teste da urease.
- C)** Iniciar tratamento com medicações que atuam na estabilização do coágulo, como os inibidores da bomba de prótons.
- D)** Iniciar tratamento medicamentoso com protetores de mucosa gastroduodenal como os antagonistas H₂.
- E)** Acesso venoso central, reposição de cristalóide e hemoderivados para manter hematócrito em torno de 30%.

86. Paciente masculino, 85 anos, diabético, hipertenso, iniciou há três dias com palpitações e tontura. Procura o serviço de emergência, onde dá entrada acordado e contactuante, ao exame: FC = 145 bpm; PA = 110/60 mmHg; ritmo cardíaco irregular, alguns estertores crepitantes em bases pulmonares. É realizado um ECG que evidencia: ausência de ondas P, irregularidade da linha de base (ondas F) e distância R-R irregular. Assinale a alternativa que apresenta a conduta MAIS ADEQUADA na emergência.

- A)** Iniciar anticoagulação + cardioversão com antiarrítmico endovenoso.
- B)** Iniciar anticoagulação + controle de frequência cardíaca.
- C)** Controle da frequência cardíaca + cardioversão com antiarrítmico endovenoso.
- D)** Iniciar anticoagulação + cardioversão elétrica.
- E)** Controle da frequência cardíaca.

87. Paciente masculino, 40 anos, procura a unidade básica de saúde para consulta de rotina. Nega queixas. É tabagista e sedentário. O médico verifica a pressão arterial, na técnica adequada, nas três medidas realizadas a PA é 138/85 mmHg. Assinale a alternativa que apresenta a conduta MAIS ADEQUADA:

- A)** Reavaliar em um ano.
- B)** Reavaliar em dois meses. Orientar mudanças de estilo de vida.
- C)** Reavaliar em um ano. Orientar mudanças de estilo de vida.
- D)** Indicar MAPA.
- E)** Reavaliar em seis meses. Orientar mudanças de estilo de vida.

88. Paciente masculino, 48 anos, é encontrado caído em via pública, sendo levado à emergência pelos bombeiros. À chegada, encontrava-se comatoso, escala de coma de Glasgow = 8 (abertura ocular = 2/ resposta verbal = 2/ resposta motora = 4). As pupilas estavam isocóricas e fotorreagentes, não havia sinais de lateralização e o padrão respiratório era normal. A pressão arterial era 110/60 mmHg; FC = 95 bpm; FR = 12 irpm; saturação de O₂ 95%. O paciente encontrava-se sudorético, ictérico +/4, hipocorado +/4, não apresentava sinais externos de trauma e observou-se a presença de hálito etílico. Com relação ao caso acima descrito, assinale a causa MAIS PROVÁVEL do coma.

- A)** Lesão neurológica supratentorial.
- B)** Lesão neurológica infratentorial.
- C)** Estado pós-ictal prolongado.
- D)** Toxicometabólica.
- E)** Hipertensão intracraniana.

89. Paciente feminina, 70 anos, procura o ambulatório de clínica médica com história de perda súbita de visão no olho esquerdo, que durou cerca de uma hora, seguida de recuperação completa; este episódio havia ocorrido há duas semanas. Naquela ocasião, havia sido avaliada na emergência, onde realizou TC de crânio, que descartou alterações isquêmicas; ECG evidenciava ritmo sinusal. Foi encaminhada para realizar um doppler de artérias carótidas, que evidenciou estenose de artéria carótida direita de 40%. Assinale as medidas ADEQUADAS na prevenção de acidente vascular cerebral no caso acima descrito.

- A)** Iniciar AAS + clopidogrel, manter pressão arterial abaixo de 140/90 mmHg, iniciar estatina.
- B)** Iniciar AAS, manter pressão arterial abaixo de 140/90 mmHg, iniciar estatina.
- C)** Iniciar warfarina + clopidogrel, manter pressão arterial abaixo de 140/90 mmHg, iniciar estatina.
- D)** Iniciar AAS + clopidogrel, manter pressão arterial abaixo de 140/90 mmHg, solicitar dosagem de níveis séricos de colesterol.
- E)** Controle de fatores de risco e encaminhar para endarterectomia de carótida.

90. Paciente masculino, 28 anos, sabidamente HIV+ há dois anos, iniciou há quatro dias com confusão mental, seguida de hemiparesia direita. É aventada a hipótese de neurotoxoplasmose. Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. Quais achados de exames complementares podem corroborar esta hipótese?

- A)** TC de crânio: múltiplas lesões hipodensas ovaladas com captação de contraste anelar predominantes em núcleos da base; sorologia para toxoplasmose IgG positiva; contagem CD4 abaixo de 200.
- B)** TC de crânio: edema cerebral e redução do tamanho dos ventrículos; sorologia para toxoplasmose IgG positiva; contagem CD4 abaixo de 200.
- C)** TC de crânio: lesão hipodensa única próxima ao ventrículo lateral esquerdo com pouca captação de contraste perilesional; sorologia para toxoplasmose IgG negativa; contagem CD4 acima de 200.
- D)** TC de crânio: sem alterações; sorologia para toxoplasmose IgG negativa; contagem CD4 acima de 200.
- E)** TC de crânio evidenciando hidrocefalia, sorologia para toxoplasmose IgG positiva; contagem CD4 abaixo de 200.

91. Paciente feminina, 18 anos, procura a emergência devido a edema de membros inferiores de caráter ascendente e progressivo, que iniciou há cinco dias. Relata quadro de febre de 38.5°C, diária, acompanhada de calafrios, há cerca de duas semanas. Chega à emergência em regular estado geral, FC = 110 bpm; PA = 110/60 mmHg; temperatura 38.9°C. Ausculta pulmonar limpa, ausculta cardíaca com sopro diastólico +/4 em foco mitral, abdome plano, sem sinais de ascite, membros inferiores com edema simétrico ++/4 até raiz de coxa; presença de lesões subungueais tipo petéquias no 3° e 4° quirodáctilos direitos. São solicitados alguns exames laboratoriais: Creatinina = 1.4 mg/dl; Ureia = 32 mg/dl; Potássio = 3.8 mEq/L; Albumina sérica = 3.2 g/dl; VHS = 120; hemocultura com crescimento de cocos Gram-positivos; Parcial de urina: hemácias = 26.000; proteínas ++; cilindros hemáticos: 1000. Assinale a alternativa que apresenta as hipóteses diagnósticas MAIS PROVÁVEIS em relação ao caso.

- A)** Síndrome nefrítica/glomerulonefrite pós-estreptocócica.
- B)** Síndrome nefrótica/lúpus eritematoso sistêmico.
- C)** Síndrome nefrótica/nefropatia por IgA.
- D)** Síndrome nefrítica/doença antimembrana basal glomerular.
- E)** Síndrome nefrítica/endocardite bacteriana.

92. Paciente masculino, 62 anos, previamente hígido, apresentou quadro de febre, prostração, disúria e dor lombar há dois dias. Procura o serviço de emergência porque está há 12 horas sem urinar. O exame físico evidencia desidratação +/4; PA 100/70 mmHg; FC 120 bpm; jugulares baixas, abdome globoso, sinal de Giordano em flanco direito. É feito o diagnóstico de sepse de foco urinário. É realizada sondagem vesical para avaliação do débito urinário. Os resultados de exames laboratoriais são: Creatinina sérica 2.5 mg/dl; Na sérico 148 mEq/l; K sérico 5.1 mEq/l; HCO₃ sérico 14 mg/dl; Na urinário 10 mEq/l; Creatinina urinária 45 mg/dl; Osmolalidade urinária 570 mOsm/kgH₂O. Assinale a alternativa que apresenta a causa de insuficiência renal e a conduta terapêutica MAIS ADEQUADAS ao quadro.

- A)** Insuficiência renal pré-renal / expansão volêmica com salina hipotônica.
- B)** Necrose tubular aguda / hemodiálise precoce.
- C)** Necrose tubular aguda / bolus de furosemida 100 mg.
- D)** Insuficiência renal pré-renal / expansão volêmica com salina isotônica.
- E)** Insuficiência renal pós-renal / manter sonda vesical de demora.

93. Paciente feminina, 20 anos, procura o pronto atendimento com queixa de dor torácica retroesternal há duas semanas acompanhada de febre de cerca de 38°C. Refere que a dor piora com a inspiração profunda e melhora quando fica com o tórax inclinado para frente. O exame físico não apresenta alterações. É realizada uma radiografia de tórax que é aparentemente normal. Também é feito um ECG que evidencia elevação do segmento ST em todas as derivações. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico MAIS PROVÁVEL.

- A)** Derrame pericárdico.
- B)** Tromboembolismo pulmonar.
- C)** Pericardite aguda.
- D)** Pneumonia atípica.
- E)** Síndrome de Dressler.

94. Analise as afirmativas abaixo acerca do cuidado de pacientes que se encontram em internação hospitalar. I. Para esses pacientes, há indicação irrestrita de profilaxia para tromboembolismo venoso com heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, ou compressão pneumática dos membros inferiores. II. O uso, como rotina, de inibidores de bomba protônica ou bloqueadores H2 para profilaxia para hemorragia digestiva por lesão aguda da mucosa gástrica não apresenta riscos. III. O controle glicêmico deve ser feito em todos os pacientes, pelo menos quatro vezes ao dia e em caso de hiperglicemia, esta deve ser corrigida para níveis euglicêmicos. IV. Durante o primeiro dia de internação, pela realização de exames diagnósticos mais frequentes, todo paciente deve ficar em dieta zero. Assinale a alternativa CORRETA.

- A)** Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- B)** Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- C)** Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- D)** Somente as afirmativas I e II são corretas.
- E)** Nenhuma afirmativa é correta.

95. Quanto à avaliação e tratamento da asma, analise as afirmativas abaixo: I. A espirometria com prova broncodilatadora ou medidas seriadas do pico de fluxo expiratório podem confirmar o diagnóstico. II. A educação do paciente é essencial para um bom controle da doença, entretanto deve ser restrita a como utilizar corretamente as medicações inalatórias. III. Uma espirometria com prova broncodilatadora normal descarta o diagnóstico. IV. A ausência de ruídos pulmonares é um sinal de gravidade durante uma exacerbação. Assinale a alternativa CORRETA.

- A)** Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- B)** Todas as afirmativas são corretas.
- C)** Somente a afirmativa I é correta.
- D)** Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- E)** Somente as afirmativas II e III são corretas.

96. Sobre a tuberculose, analise as afirmativas abaixo. I. Os pacientes com diagnóstico de tuberculose latente devem receber terapia rotineiramente semelhante ao de um paciente bacilífero. II. Pela gravidade clínica, o tratamento para meningoencefalite tuberculosa deve ser iniciado empiricamente quando o diagnóstico é suspeito, mesmo antes da confirmação microbiológica. III. O tratamento hospitalar deve ser reservado para os pacientes com gravidade clínica e ou sem condição social para tratamento ambulatorial. IV. Somente os casos de tuberculose pulmonar bacilífera devem ser notificados à vigilância epidemiológica. Assinale a alternativa CORRETA.

- A)** Somente a afirmativa I é correta.
- B)** Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- C)** Todas as afirmativas são corretas.
- D)** Somente as afirmativas II e III são corretas.
- E)** Somente as afirmativas I e II são corretas.

97. Um paciente é internado na emergência com diagnóstico de cetoacidose diabética e, após a administração inicial de 8 UI de insulina regular endovenosa e cinco horas de infusão endovenosa contínua de insulina regular a uma taxa de 8 UI/h, apresentou hipoglicemia, com glicemia capilar de 59 mg/dl. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao caso.

- A)** A administração endovenosa de glicose está contraindicada em pacientes com cetoacidose diabética.
- B)** A hipoglicemia deve ser corrigida através da administração de glicose endovenosa e/ou, se possível, através da ingesta alimentar.
- C)** A correção da hiperglicemia é o suficiente para reverter a cetoacidose diabética.
- D)** A insulinoaterapia agressiva pode acarretar hiperpotassemia.
- E)** A evolução rápida para hipoglicemia descarta o diagnóstico inicial de cetoacidose diabética.

98. Analise as afirmativas abaixo. I. O hipotireoidismo primário é caracterizado por uma supressão dos níveis séricos de TSH. II. A hiperpigmentação da pele é um achado típico da insuficiência adrenal secundária. III. No acompanhamento clínico de um paciente com hipotireoidismo secundário, o nível sérico de TSH não tem valor para guiar a dose de hormônio tireoideo. IV. A hipersecreção do hormônio do crescimento pode elevar a glicemia até níveis compatíveis com diabetes mellitus. Assinale a alternativa CORRETA.

- A)** Todas as afirmativas são corretas.
- B)** Somente as afirmativas I e II são corretas.
- C)** Somente a afirmativa III é correta.
- D)** Somente a afirmativa II é correta.
- E)** Somente as afirmativas III e IV são corretas.

99. Paciente feminina, 29 anos, busca atendimento de emergência devido à dor ventilatório-dependente em hemitórax esquerdo iniciada dois dias antes. Durante a avaliação, a paciente revelou ter iniciado há um mês com quadro de artralguas simétricas (principalmente em punhos, joelhos e tornozelos), febre não aferida, queda capilar excessiva, com emagrecimento de 3 kg no período. Ao exame apresenta como alterações: palidez cutâneo-mucosa ++/4+, Tax 37.6°C, e murmúrio vesicular ausente em terço inferior de hemitórax esquerdo. A radiografia de tórax demonstra derrame pleural livre à esquerda; o hemograma apresenta Hb 9,2 g/dl com índices hematimétricos normais e plaquetas 99.000/mm³; e o exame parcial de urina demonstra hematúria com cilindros hemáticos. Considerando a avaliação diagnóstica do caso acima, assinale a alternativa CORRETA.

- A)** Não se deve considerar o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico para esta paciente, visto que claramente trata-se de um quadro infeccioso.
- B)** A paciente acima apresenta pelo menos três critérios diagnósticos de lúpus eritematoso sistêmico: serosite e manifestações hematológica e renal.
- C)** A ausência de manifestações cutâneas descarta o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico.
- D)** O único critério diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico que está ausente é o anticorpo antinuclear.
- E)** O diagnóstico de nefrite lúpica somente será fechado com a presença de anticorpo anti-DNA.

100. Paciente masculino, 54 anos, com diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) há dois anos, dá entrada na emergência. Conforme os familiares, o paciente encontrava-se acamado, com incapacidade funcional total e há um dia evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, respiração ruidosa e presença de secreção purulenta na cavidade oral. Ao exame apresenta-se comatoso (escala de Glasgow = 3), FR 10 irpm, respiração tipo gasping, saturação de O₂ 77% com O₂ suplementar sob máscara a 10 l/min, PA 70/30 mmHg, FC 46 bpm, ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, sem sopros; e murmúrio vesicular difusamente diminuído. Na radiografia de tórax apresentava consolidação em lobo inferior direito. Sobre o caso acima, analise as afirmativas abaixo. I. É essencial oferecer suporte e informações aos familiares, visto que o paciente está morrendo e pneumonia é uma causa frequente de morte em paciente com estado avançado de ELA. II. Visto tratar-se de uma doença avançada e incurável, é essencial evitar procedimentos invasivos e ou desconfortáveis e oferecer cuidados paliativos adequados ao paciente. III. O paciente necessita urgentemente de traqueostomia para que se possa oferecer ventilação mecânica em longo prazo. IV. É necessário administrar urgentemente antibiótico, assim como iniciar reposição volêmica e droga vasoativa, como indicado para as fases iniciais do choque séptico. Assinale a alternativa CORRETA.

- A)** Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- B)** Somente a afirmativa I é correta.
- C)** Somente as afirmativas I e II são corretas.
- D)** Somente a afirmativa II é correta.
- E)** Somente as afirmativas I e III são corretas.

GABARITO

1 - C	2 - A	3 - B	4 - E	5 - D
6 - C	7 - A	8 - E	9 - B	10 - D
11 - A	12 - E	13 - B	14 - D	15 - B
16 - A	17 - E	18 - B	19 - D	20 - E
21 - A	22 - C	23 - E	24 - B	25 - D
26 - E	27 - A	28 - B	29 - D	30 - C
31 - E	32 - A	33 - D	34 - A	35 - B
36 - E	37 - C	38 - A	39 - D	40 - B
41 - E	42 - C	43 - E	44 - B	45 - D
46 - A	47 - C	48 - B	49 - A	50 - E
51 - D	52 - B	53 - E	54 - C	55 - D
56 - A	57 - B	58 - D	59 - C	60 - A
61 - E	62 - B	63 - D	64 - C	65 - A
66 - E	67 - B	68 - A	69 - E	70 - C
71 - B	72 - E	73 - D	74 - A	75 - C
76 - A	77 - E	78 - B	79 - D	80 - B
81 - A	82 - E	83 - A	84 - E	85 - C
86 - B	87 - E	88 - D	89 - B	90 - A
91 - E	92 - D	93 - C	94 - E	95 - A
96 - D	97 - B	98 - E	99 - B	100 - C